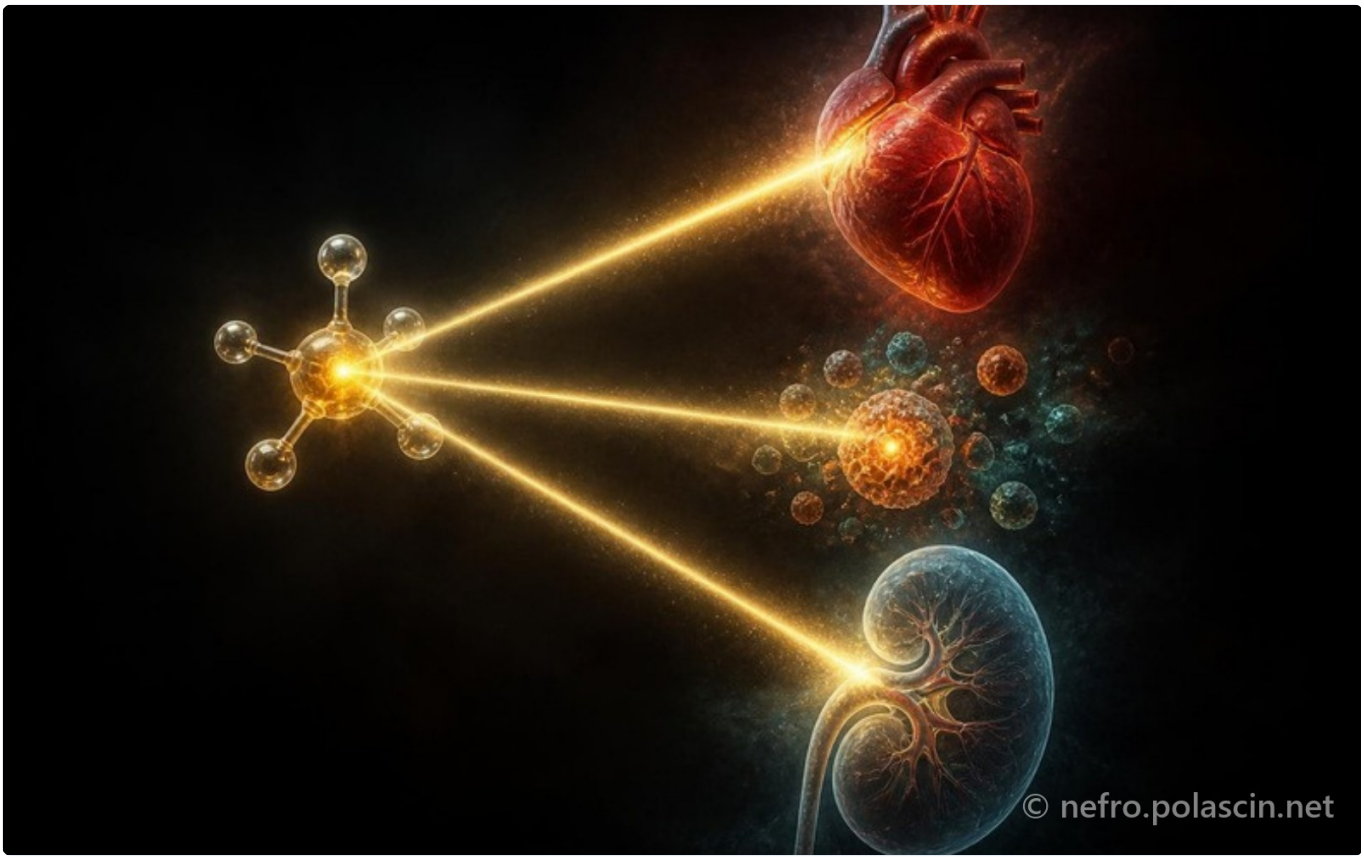
Finerenón naprieč štádiami kardiovaskulárno-obličkovo-metabolického (CKM) syndrómu u pacientov s DM2 a CKD: čo prináša post-hoc analýza FIDELITY

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 05.11.2026



Poloschematická vizualizácia. Účinok nemieri na jediný orgán – a práve preto dáva zmysel hodnotiť ho naprieč celým CKM syndrómom.

Pacienti s diabetes mellitus 2. typu (DM2) a chronickou chorobou obličiek (CKD) tvoria skupinu s vysokým rizikom kardiovaskulárnych aj renálnych príhod. V praxi sú však diagnostika a riziková stratifikácia často „fragmentované“: nefrológ rieši obličky, kardiológ srdce a metabolické faktory zostávajú mimo hlavného rozhodovania.

Preto dáva zmysel koncept CKM syndrómu (cardiovascular-kidney-metabolic), ktorý spája obezitu/metabolické riziká, diabetes, CKD a kardiovaskulárne ochorenie do jedného klinického rámca. Článok v Medscape zhŕňa výsledky post-hoc analýzy dvoch randomizovaných štúdií FIDELITY, ktorá hodnotila, či liečba finerenónom prináša konzistentný prínos naprieč CKM štádiami.

Dizajn a populácia

- Ide o **post-hoc združenú (pooled) analýzu dvoch fáz 3 randomizovaných, dvojito zaslepených, placebom kontrolovaných štúdií FIDELITY**.
- Zaradených bolo **12 990 pacientov** (priemerný vek 64,8 roka; 70 % mužov), so sérovým **K+ ≤ 4,8 mmol/l** a liečených **maximálne tolerovanou inhibíciou RAAS**.
- Pacienti so symptomatickým **HFrEF** boli zo štúdií vylúčení.
- Pacienti boli podľa **CKM štádia východiskovo** rozdelení na:
    - **štádium 2**: metabolické rizikové faktory alebo stredné až vysoké riziko CKD (n = 3864)
    - **štádium 3**: veľmi vysoké riziko CKD (n = 3275)
    - **štádium 4**: klinické kardiovaskulárne ochorenie (n = 5851)

- Primárne sledované boli:
    - **kardiovaskulárny kompozit** (kardiovaskulárna smrť, nefatálny IM, nefatálna CMP, hospitalizácia pre zlyhávanie srdca)
    - **renálny kompozit** (zlyhanie obličiek, pretrvávajúci pokles eGFR o ≥ 57 % oproti východisku po ≥ 4 týždňoch alebo smrť z renálneho zlyhania)
- Medián sledovania bol **3 roky**.

Kľúčové výsledky

1) Vyššie CKM štádium znamená vyššie riziko

CKM **štádium 4** bolo spojené s vyšším rizikom oproti štádiu 2:

- **kardiovaskulárny kompozit**: aHR **1,87** (95 % IS 1,56–2,24)
- **renálny kompozit**: aHR **1,96** (95 % IS 1,43–2,69)

Zodpovedá to klinickému očakávaniu; podstatné je, že stratifikácia podľa CKM štádia funguje konzistentne aj v klinickom skúšaní.

2) Finerenón znižoval riziko nezávisle od CKM štádia

Finerenón znížil:

- **kardiovaskulárny kompozit** aj pri rôznych CKM štádiách (P pre interakciu **0,86**)
- **renálny kompozit** naprieč CKM štádiami (P pre interakciu **0,65**)

Prínos bol teda konzistentný bez ohľadu na východiskový rizikový profil podľa CKM.

3) Okrem prínosu v príhodách: aj priaznivejšia dynamika CKM

V skupine na finerenóne sa pozorovala priaznivejšia zmena CKM stavu v čase:

- **CKM regresia zo štádia 3 do 2**: vyššia pravdepodobnosť pri finerenóne (odds ratio 1,66; **P < 0,001**)
- **CKM progresia**: menej častá, rozdiel bol však len na hranici štatistickej významnosti (aOR 0,89; **P = 0,05**)

4) Bezpečnosť naprieč CKM štádiami

Bezpečnostný profil finerenónu bol **podobný naprieč CKM štádiami** a nepozoroval sa rozdielny nárast rizika **hyperkaliémie podľa štádia**.

Prečo je to zaujímavé pre nefrológiu

Pre nefrológiu je dôležité, že výsledok podporuje predstavu finerenónu ako lieku, ktorý nie je „len renálny“ ani „len kardiálny“, ale pravdepodobne zasahuje spoločné dráhy, ktoré vedú k renálnym aj kardiovaskulárnym príhodám. CKM rámec navyše naznačuje, že pacient môže mať komplexné riziko aj bez toho, aby bolo v klinickej dokumentácii explicitne pomenované ako jedna jednotka.

Treba však pamätať, že ide o post-hoc analýzu; hodnotenie podľa CKM štádií nebolo primárnym cieľom štúdií.

Limity a opatrná interpretácia

Medscape aj pôvodná práca zdôrazňujú obmedzenia:

- **Štúdie FIDELITY neboli pôvodne navrhnuté na skúmanie účinkov finerenónu na CKM syndróm**, takže niektoré podskupiny majú obmedzené počty a nie všetky potrebné premenné boli systematicky zbierané pre úplnú klasifikáciu CKM štádií.
- Post-hoc charakter znižuje istotu kauzality a robí z výsledkov skôr potvrdenie konzistencie než „definitívny dôkaz“ pre CKM rámec ako liečebný cieľ.

Záver

V post-hoc združenej analýze FIDELITY finerenón **znižoval kardiovaskulárne aj renálne príhody konzistentne naprieč CKM štádiami** u pacientov s DM2 a CKD. Štádium 4 bolo spojené s vyšším rizikom, no prínos finerenónu sa ukázal aj u pacientov s vyššou východiskovou záťažou. Navyše sa pozorovala priaznivejšia dynamika CKM (regresia zo štádia 3 do 2) a bezpečnosť vrátane rizika hyperkaliémie bola porovnateľná naprieč štádiami.

Zdroj: *Kevin Bryan Lo, John W. Ostrominski, et al. (FIDELITY post-hoc analýza), JAMA Cardiology (2026) – spracované v Medscape Medical News: „Finerenone Benefits Patients With T2D, CKD Across Cardiovascular-Kidney-Metabolic...“. Medscape · PubMed.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=finerenon-ckm-syndrom-dm2-ckd-fidelity · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.